# Infarto de miocardio

FISIOPATOLOGIA · Clase 18 · de la placa rota a la onda Q: isquemia, lesión y necrosis, y qué arteria se tapó

## 1 · QUÉ ES EL INFARTO Y POR QUÉ OCURRE

F23 **Factores de riesgo**
edad, diabetes, HTA mal controlada, obesidad, sedentarismo, tabaco y estrés (la actividad física NO es riesgo)

aceleran la formación de la

F14 **Arterioesclerosis**
causa del 90 % de los infartos: placa de colesterol, triglicéridos, plaquetas y calcio que estrecha la coronaria

*al faltar riego da primero*

en menor proporción, en el joven, es

F25 **Adulto joven con arterias limpias**
sospechar vasoespasmo por cocaína o émbolos

al fisurarse la placa produce la

F14 **Oclusión**
la placa se fisura, se forma un trombo y la arteria se cierra: el músculo queda sin riego

afecta sobre todo al

F18 **Ventrículo izquierdo**
se infarta más porque tiene mayor masa y pide más riego

al faltar riego causa el

F24 **Dolor torácico opresivo**
se irradia a cuello, mandíbula y brazo izquierdos

obliga a pedir el

F24 **ECG obligatorio**
confirma el daño y localiza la pared

*la misma placa produce la*

## 2 · TRES GRADOS DE DAÑO: ISQUEMIA, LESIÓN Y NECROSIS

F2 **Isquemia**
zona superficial, reversible: onda T invertida (negativa)

si persiste, avanza a

F4 **Lesión**
zona intermedia, reversible: ST supradesnivelado (convexo)

si no se reabre la arteria, llega a

F3 · F22 **Necrosis**
zona central, músculo inerte e irreversible: Q patológica (más de 0,04 s y/o más del 25 % de la R)

*si no atraviesa la pared, muestra*
*en la fase aguda dura*

*lo produce la*

*es la onda que permanece como*

## 3 · EVOLUCIÓN DEL ECG EN EL TIEMPO

F20 **Subendocárdico puro**
no atraviesa la pared: ST descendido, T positiva y Q normal

F4 **Fase aguda**
ST elevado durante 2 a 3 horas (corriente de lesión)

con las horas pasa a la

F15 **Fase subaguda**
aparece la Q, el ST vuelve a la basal y la T sigue negativa

con los meses pasa a la

F21 **Fase crónica (infarto antiguo)**
Q + T negativa, sin ST elevado; la T tarda meses o años en normalizarse

deja como cicatriz la

La Q queda de por vida: marca el músculo muerto

si el ST sigue elevado, sospechar

F5 **Aneurisma ventricular**
si el ST sigue elevado días o meses, la pared necrótica se abomba

*si V1-V4 están alteradas, es*
*si solo D1 y aVL, es*
*si hay espejo en V1-V2, es D2, D3 y aVF, es*

## 4 · QUÉ PARED Y QUÉ DERIVACIONES

F6 **Anteroseptal**
derivaciones V1-V4

F11 **Lateral alto**
solo D1 y aVL

F16 **Inferior (diafragmático)**
D2, D3 y aVF

F1 **Anterior extenso**
D1, aVL y V1-V6: casi todo el VI; el más peligroso

F17 **Posterior**
imagen en espejo en V1-V2: R alta y ST descendido

debe distinguirse de la

F17 **Diagnóstico diferencial**
la hipertrofia ventricular derecha también da R alta en V1

*lo produce la circunfleja o la*
*lo produce con frecuencia la*
*se controla con*
*lo produce la*
*lo produce la*

## 5 · QUÉ ARTERIA Y QUÉ COMPLICACIÓN

F10 **Circunfleja**
infarto lateral alto; de ella sale la arteriola del nódulo sinusal

al faltar riego al sinusal puede dar

F10 **Fibrilación auricular**
por el nódulo sinusal sin riego

F11 **Diagonal**
lateral alto (D1, aVL, V5, V6)

al dañar el músculo del VI produce

**Arritmias ventriculares**
extrasístoles, taquicardia ventricular y paro sistólico

si no se corrigen terminan en

Paro cardiaco si la arritmia no se corrige

F7 **Descendente anterior proximal**
riega casi todo el VI: da el anterior extenso

al inutilizar el VI produce

F1 · F19 **Insuficiencia izquierda y edema agudo de pulmón**
el VI no bombea y la sangre se estanca en el pulmón

si la necrosis pasa del 40 %, termina en

F8 **Shock cardiogénico**
necrosis mayor del 40 % del VI: la bomba no basta

al faltar riego al NAV da

F9 **Bloqueo AV**
el impulso no pasa a los ventrículos

si es avanzado, requiere

Se necesita marcapaso

F9 **Coronaria derecha**
infarto inferior; de ella sale la arteriola del NAV

también puede causar

**Insuficiencia cardiaca derecha**
si se daña el VD en el infarto inferior

se trata corrigiendo la causa y con

Vigilancia con ECG seriado y tratamiento de la complicación

**Descendente anterior terminal**
compromete el tabique (anteroseptal)

al dañar el tabique da

**Bloqueos de rama e IC izquierda**
por daño del tabique

se maneja con

*por trombos auriculares puede causar*

## 6 · LA MISMA PLACA EN EL CEREBRO: ACV

**Aterosclerosis sistémica**
la misma placa afecta carótidas, arteria subbasilar y arterias renales

si un émbolo cardiaco llega, da

si se rompe una arteria de Willis, da

F12 **ACV isquémico embólico**
los émbolos salen siempre del corazón (estenosis mitral con aurícula dilatada o dilatación cardiaca)

F13 **ACV hemorrágico**
ruptura de arterias del polígono de Willis por HTA severa o aneurisma congénito

causa · ejemplo · mecanismo · concepto · síntoma · diagnóstico · desenlace · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 24 · Dr. Sotito — teoría del docente ( = literatura)